



2026-03-27 | ■■■ PPTX

本体 +3.09%

30 年ぶりの大幅引き上げ

内訳	改定率
賃上げ	+1.70%
物価高騰	+0.76%
食費・光熱水費	+0.09%

この改定で「あなたの給料」は上がるのか？
そして「あなたの診療」はどう変わるのか？

今日の学習目標

この 15 分の後、あなたは：

- 1 説明できる — 2026 年度改定の全体像と 4 つの柱（理解）
- 2 整理できる — 外来・入院・救急・連携の設定別に改定ポイントを分類（分析）
- 3 提案できる — 自院での BCP 策定・医療 DX 対応の具体的アクション（創造）

前提確認 — Quick Poll

- ☒ 前回（2024 年度）の改定内容を覚えている人？
- ☒ 「生活習慣病管理料」を算定したことがある人？
- ☒ 「地域包括診療加算」の施設基準を知っている人？
- ☐ BCP って何の略？（Business Continuity Plan）

2024 年改定では生活習慣病管理料の見直しや医療 DX 推進体制整備加算が新設。
2026 年改定はその延長線上にありつつ、大幅な再編が行われています。

改定全体像 — 4つの柱

柱	内容	総合診療との関連
1. 賃上げ・物価対応	ベースアップ評価料拡充、物価対応料新設	全スタッフの給与に直結
2. 医療 DX 推進	既存加算廃止→電子的診療情報連携体制整備加算に統合	マイナ保険証利用率が算定に影響
3. かかりつけ医機能強化	地域包括診療加算 / 料の再編、BCP 義務化	家庭医の中核業務そのもの
4. 急性期再編と連携強化	入院料の細分化、救急外来の新評価	病院総合診療科・救急の評価が変わる

設定別ポイント (A) 外来 (診療所)

項目	変更内容	ポイント
再診料	75 点→ 76 点 (+1 点)	微増だが全再診に影響
機能強化加算	80 点維持 + BCP 策定が施設基準追加	経過措置 : 2027 年 5 月末
地域包括診療加算	認知症地域包括加算を統合・2 区分化	加算 1:(1)38 点 /(2)28 点
生活習慣病管理料	眼科・歯科連携加算を新設	糖尿病合併症予防
物価対応料	初診 2 点 / 再診 2 点 (新設)	2027 年度に倍増予定
ベースアップ評価料 (I)	6 点→ 17 点 (+11 点)	全職員対象に拡大
外来データ提出加算	10 点 / 月 (新設)	データ継続提出で加算

設定別ポイント（B）入院（病院総合診療科）

項目	変更内容	ポイント
地域包括医療病棟	6 区分に細分化（3367-3066 点）	急性期併設有無・救急 / 予定で区分
地域包括ケア病棟	入院料 1: 2838→2955 点	包括期医療の充実評価
総合的診療機能	小児・周産期等の幅広い対応を高評価	「地域最後の砦」に有利
急性期一般入院料	新区分の新設	高度 / 一般の役割分担加速
入院時物価対応料	新設	食材費・光熱水費対応

地域包括医療病棟の細分化→「どの区分を取るか」が経営戦略に直結

設定別ポイント（C）救急 +（D）連携

救急

項目	変更内容
院内トリアージ	廃止→体制加算に再編
ウォークイン患者	夜間休日にも加算可能に
時間外救急搬送加算	休日夜間 300/ 平日夜間 250/ 休日日中 200 点
救急患者連携搬送料	+600 点の引き上げ

診療所 ⇄ 病院連携

項目	変更内容
紹介患者受入加算	60 点（新設）
救急患者連携搬送料	高次→地域の転院搬送を評価
電子的診療情報連携	電子カルテ情報共有サービス
眼科・歯科連携加算	新設（多職種連携）

医療 DX と BCP — 2 つの必須対応

医療 DX の再編

区分	初診点数	主な要件
区分 1	15 点	電子処方箋実績 + 共有サービス + マイナ 30% 以上
区分 2	9 点	電子処方箋体制 + DX システム整備
区分 3	4 点	マイナ保険証利用体制 + 基本 DX

BCP 策定義務化

- 機能強化加算の施設基準に BCP 追加
- 在支診・在支病の施設基準にも追加
- 経過措置 : 2027 年 5 月 31 日まで
- 災害対応 + サイバーセキュリティ対策

ケースディスカッション

あなたは地方の 200 床の病院で総合診療科の専攻医です。
院長から「今回の改定で当院がとるべきアクションをまとめてほしい」と言われました。

問い 1: 外来部門で最優先で対応すべき改定項目は何か?

問い 2: 入院部門（地域包括医療病棟）でどの区分を目指すべきか?

問い 3: 救急部門で新しく算定できる加算は何か?

ペアワーク 3 分 → 2-3 ペアからシェア

振り返りと持ち帰りの問い

理解度チェック（挙手）

- 改定の 4 つの柱を 2 つ以上言える？
- 機能強化加算に BCP が必要なことを覚えた？
- 医療 DX 加算が 3 区分になったことを理解した？

持ち帰りの宿題

- 来週：マイナ保険証利用率を確認する
- 来月：BCP 策定の現状を上司に確認する
- 6 月まで：自分の設定での算定変更を 1 つ把握する

スケジュール

時期	やるべきこと
今すぐ	マイナ保険証利用率の確認
2026 年 4 月	告示・通知の詳細確認
2026 年 5 月	新加算の届出提出
2026 年 6 月 1 日	改定施行日
2027 年 5 月末	BCP 策定の経過措置期限



2/17

本体 +3.09%

30 年ぶりの大改定 — あなたの生活に直結します

内訳	割合
賃上げ	+1.70%
物価高騰対応	+0.76%
食費・光熱水費	+0.09%
経費改善	+0.44%

今回の改定は、皆さんの給与・処遇に直接つながる改定です。

今日知ってほしいこと

この 10 分の後、あなたは：

- 1 わかる — 今回の改定が自分の給与・業務にどう影響するか
- 2 できる — BCP 策定への自分の役割を説明できる
- 3 判断できる — マイナ保険証の案内など、優先すべきことを選べる

あなたの給与に関わる 3 つの変更

1 ベースアップ評価料の大幅拡充

	旧	新
初診時加算	6 点	17 点 (+11 点)
対象職員	主に医療従事者	事務職員含む全職員

2 物価対応料の新設

場面	点数
初診時	2 点
再診時	2 点
訪問診療時	3 点

3 再診料の引き上げ : 75 点 → 76 点 (+1 点)

小さな変化に見えますが、全患者の再診に影響するため病院全体では大きな収入増。

業務で変わること — DX と BCP

マイナ保険証の利用率が病院の収入に直結

区分	点数	主な要件
区分 1	15 点	マイナ利用率 30% 以上 + 電子処方箋
区分 2	9 点	電子処方箋体制あり
区分 3	4 点	マイナ保険証基本体制のみ

BCP（事業継続計画）の策定が義務化

- 災害やサイバー攻撃でも診療を続ける計画
- 機能強化加算・在支診 / 在支病の施設基準に追加
- 経過措置：2027 年 5 月末まで
- 「災害時にあなたは何かをするか」を決める

窓口スタッフの皆さんへ：マイナ保険証利用の声かけが病院の収入に直結します。

部署別 — 明日からできること

部署	明日からのアクション
受付・医事課	マイナ保険証利用の積極的な声かけ、利用率の把握
看護部	BCP 策定への参加、院内トリアージ体制の確認
リハビリ・コメディカル	地域包括ケア病棟の加算変更の把握、多職種連携の記録
事務・総務	BCP 策定の全体調整、届出書類の準備、レセプトシステム更新
医師	生活習慣病管理での眼科・歯科連携、電子処方箋の発行推進

グループ対話

隣の人と話してみましょう（2分）

今日聞いた改定内容の中で、あなたの日常業務に一番影響がありそうなのは何ですか？

- 「受付でマイナ保険証の声かけを増やさないと…」
- 「BCP って、うちの部署ではどうなるんだろう？」
- 「ベースアップ評価料の拡大、給与にいつ反映？」

まとめと次のアクション

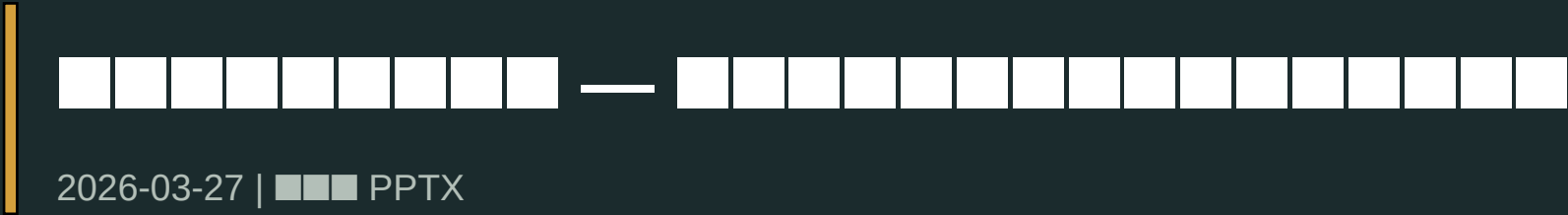
3つだけ覚えてください

#	ポイント	キーワード
1	賃上げ原資が大幅増	ベースアップ評価料 17 点、全職員対象
2	マイナ保険証の声かけが収入直結	利用率 30% で区分 1 （15 点）
3	BCP 策定に全員参加	2027 年 5 月末までに策定

スケジュール

時期	やること
今日	BCP に関して自部署の状況確認
今月中	マイナ保険証の案内方法を見直す
2026 年 6 月	改定施行 — 新しい運用開始
2027 年 5 月末	BCP 策定の経過措置期限

「明日、1つだけ変えるとしたら何を変えますか？」



2026-03-27 | ■■■ PPTX

研究倫理指針の一部改正

— 研究を始める前に知っておくべきこと

研修医・指導医向け | 15 分 | 2026-03-27

2026 年度、研究倫理指針が改正されます。
文科省・厚労省・経産省の 3 省庁合同改正。
パブリックコメント終了済み。

問い：

あなたが今書いている研究計画書、
新指針で何が変わるか答えられますか？

今日の学習目標

この 15 分の後、あなたは：

- 1 説明できる — 改正で何が変わるのか、3つの柱を述べられる（理解）
- 2 分析できる — 自分の研究計画に影響する変更点を特定できる（分析）
- 3 作成できる — 新指針に準拠した研究計画書の骨子を書き始められる（創造）

まず確認 — 現行指針、どこまで知っていますか？

Quick Poll (挙手)

- 「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」を読んだことがある人？
- IC とオプトアウトの違いを説明できる人？
- 自分の研究で仮名加工情報を扱ったことがある人？

今日は「同意のとり方」と「個人情報の種類」の2つを軸に、改正のポイントを整理します。

現行指針の基本構造

章	内容
第 1 章	総則（目的・適用範囲・定義）
第 2 ～ 7 章	研究実施の手続（計画書・IC・試料管理等）
第 8 章	倫理審査委員会
第 9 章	個人情報等・匿名加工情報の取扱い

改正の 3 つの柱

柱 1

同意手続きの簡素化・一元化

改正前：IC 手続きが複雑に分岐

改正後：IC とオプトアウトに二元化

柱 2

仮名加工情報・匿名加工情報の 取扱い明確化

種類	改正のポイント
仮名加工情報	自機関作成 → IC は必ずしも不要 (オプトアウトで可)
匿名加工情報	「困難な場合」制限撤廃 → 幅広く 利用可能
個人関連情報	個人情報保護法に沿った取扱いを明 確化

柱 3

包括同意からオプトアウトへ の 移行ルール

改正前：包括同意の扱いが不明確

改正後：包括同意 + オプトアウト

= 新たな IC なしで研究利用可能

同意の 3 類型を整理する

同意の種類	何をするか	いつ使うか	改正での位置づけ
IC	研究内容を説明し書面同意を取得	侵襲を伴う研究、新規試料採取	引き続き必要な場面あり
オプトアウト	研究情報を公開し拒否機会を保障	既存試料・情報、仮名加工情報	改正で適用範囲が拡大
包括同意	将来の研究利用含む広範な同意	バイオバンク、大規模コホート	単独では不十分→オプトアウトと組合せ

判断フローチャート

研究で使うデータは？

└ 新規採取・侵襲あり
└ → IC 必須

└ 既存の試料・情報
└ └ 匿名加工情報 → 同意不要
└ └ 仮名加工（自機関）→ オプトアウト
└ └ その他 → オプトアウトが基本

└ 包括同意取得済み
→ 範囲内特定 + オプトアウト → 利用可

ミニ研究計画書ワーク

ペアワーク（4分）：シナリオを1つ選び、研究計画書の骨子を作成

A: カルテ後方視的研究

糖尿病患者の治療アウトカムを
過去5年分のカルテデータで解析。
対象：自施設約500名。侵襲なし。

B: 多施設バイオバンク研究

バイオバンク保管の血液検体
（包括同意取得済み）で
新バイオマーカー探索。

C: AI 診断支援ツール精度評価

既存画像データ（匿名化済み）で
AI診断ツールの精度を検証。
他施設からのデータ提供あり。

記入シート項目：

- 研究タイトル / 研究デザイン / 対象者
- データの種類（個人情報 / 仮名加工 / 匿名加工）★
- 同意の方法（IC / オプトアウト / 不要）★
- 改正で変わるポイント / 倫理審査の要否

フィードバック — 各シナリオの答え合わせ

シナリオ	データの種類	同意の方法	改正で変わること
A: カルテ後方視	既存個人情報→仮名加工推奨	オプトアウトで OK	現行では IC 必要だったケースが簡素化
B: バイオバンク	包括同意取得済みの試料	包括同意 + オプトアウト	包括同意だけでは不十分が明確化
C: AI 画像データ	匿名加工情報	同意不要	「困難な場合」制限が撤廃

振り返りの問い

- あなたが選んだシナリオで、改正前後で手続きはどう変わりましたか？
- その変更は研究を進めやすくする方向？ 慎重にする方向？

持ち帰り — 明日から使える 3 つのアクション

今日のまとめ：3 つの変更

- 1 同意手続きの二分化 — IC とオプトアウトの 2 本柱にシンプル化
- 2 仮名加工情報のオプトアウト利用 — 自機関作成なら IC なしで OK
- 3 匿名加工情報の制限撤廃 — より幅広いデータ利活用が可能に

あなたの次のアクション（1 つ選んでください）

- ☐ 今すぐ：自分の研究の同意手続きが改正でどう変わるか確認する
- ☐ 今週中：倫理審査委員会の事務局に新指針への移行スケジュールを問い合わせる
- ☐ 来月：新指針に準拠した研究計画書のドラフトを書いている



4/17

新・家庭医療専門医制度の改訂

ポートフォリオ 2 割削減とかかりつけ医機能報告制度

これは「楽になった」のか？ それとも「質がもっと問われる」のか？

今日の学習目標（15 分）

- 説明できる — 制度変更の具体的内容と背景（理解）
- 比較できる — 旧制度と新制度の差分を分析（分析）
- 立案できる — ポートフォリオ戦略を描ける（創造）

20 → 16

ポートフォリオ領域 2 割削減

学会発表 3 件→2 件

Quick Poll — 今の知識を確認しよう

事象 3: 前提条件の想起 | 2-4 分

☒ 新・家庭医療専門医制度のポートフォリオを書いたことがある人？

☒ 「かかりつけ医機能報告制度」という言葉を聞いたことがある人？

☒ 第 17 回 JPCA 学術大会（2026 年 5 月・京都）に参加予定の人？

今、専門医制度と医療政策が同時に大きく動いています。研修医・専攻医にとって「制度を知る」ことは、キャリア戦略そのものです。

ポートフォリオ領域の前後比較

事象 4: 新しい内容の提示 | 4-7 分

削減された 4 領域（旧 17-20）→ 統合先

旧 #	削減された領域	統合先
17a	複雑困難事例のケア	→ 多疾患併存 (4) ・ 慢性疾患 (3)
17b	統合されたケア	→ チーム医療 (12) ・ 地域志向 (8)
18a	プロフェッショナリズム	→ 医療者自身のケア (16)
18b	倫理的困難な意思決定	→ 患者中心の医療 (6)
19a	セクシャルヘルス	→ 各関連領域
19b	思春期のケア	→ 各関連領域
20a	緩和ケア	→ 長期的な全人的関係 (5)
20b	人生の最終段階のケア	→ 長期的な全人的関係 (5)

コア 16 領域は変更なし

- 1. 未分化な健康問題
- 2. 予防医学と健康増進
- 3. 慢性疾患のケア
- 4. 多疾患併存
- 5. 長期的な全人的関係
- 6. 患者中心の医療
- 7. 家族志向のケア
- 8. 地域志向の PC
- 9. 障害とリハビリ
- 10. 臨床における教育
- 11. EBM の実践
- 12. チーム医療
- 13. システム思考
- 14. メンタルヘルス
- 15. 社会的決定要因
- 16. 医療者自身のケア

領域が「消えた」のではなく、既存領域に統合された。
1 つのポートフォリオに求められる多面性と深さがむしろ増している。

その他の変更 + かかりつけ医機能報告制度

事象 4+5 | 7-9 分

項目	旧制度	新制度
ポートフォリオ領域数	20 領域	16 領域
学会発表必要件数	3 件以上	2 件以上
適用開始	—	2025 年 3 月修了者～

かかりつけ医機能報告制度

項目	内容
根拠法	2023 年医療法改正
施行	2025 年 4 月
初回報告	2026 年 1 月～ 3 月（G-MIS）
報告内容	17 診療領域・40 疾患対応力 等
目的	患者が医療機関を選べるように

家庭医療専門医の研修で培う能力 ⇨ かかりつけ医機能報告で求められる能力
あなたの存在が、医療機関の「かかりつけ医機能」を高める

- 報告制度の 17 診療領域 ⇨ 家庭医が日常的に扱う領域
- 「総合診療専門医を配置しているか」が報告項目に含まれる
- あなたの存在が医療機関の「かかりつけ医機能」を高める

ペアディスカッション — 自分の戦略を考える

事象 6+7: 練習 + フィードバック | 9-13 分 | ペアワーク 3 分 + 共有 1 分

問い A (専攻医向け)

ポートフォリオが 16 領域になった今、残りの研修期間でどの領域を「質の高い事例」として書きたいか？ その理由は？

問い B (研修医向け)

かかりつけ医機能報告制度で求められる能力のうち、今の研修で意識的に伸ばせるものは何か？

問い C (指導医向け)

ポートフォリオの領域が統合された今、指導でどんな点を強調するか？

隣の人とペアを組み、3 つの問いから 1 つ選んで話し合ってください

振り返りと持ち帰り

事象 8+9 | 13-15 分

1. 量から質へ

20→16 領域の削減は、1 事例あたりの深さ・多面性を重視する方向

2. 制度と教育の融合

かかりつけ医機能報告制度と専門医研修は同じ方向を向いている

3. あなたの価値

総合診療 / 家庭医療専門医は、これからの医療制度で求められる存在

持ち帰りの問い

「自分のポートフォリオで一番自信のある領域と、一番苦手な領域は何か？
苦手な領域を、どの臨床場面で経験できるか？」

次のアクション

- JPCA 公式サイトで新 16 領域の詳細を確認
- 第 17 回 JPCA 学術大会（5/29-31 京都）の演題募集チェック
- 指導医とポートフォリオ進捗を振り返る機会を設定



2026-03-26 | ■■■■ PPTX

地域で支える緩和ケア ― 私たちにできること

対象：全スタッフ（看護師・介護士・事務職員・リハビリ職等）

所要時間：20 分

ID モデル：ガニエの9 教授事象

作成日：2026-03-26

スライド 1: タイトル

所要時間 : 20 分

今日のルール : 正解を求めません。感じたことを大切にしてください。

スライド 2: 問いかけ（注意の喚起）

「この方、最近つらそうだな」
「もう少し何かできることがあるんじゃないかな」

と感じたことはありませんか？

→ その「気づき」こそが、緩和ケアの出発点です。

☒ ガニエ第 1 事象：学習者の注意を喚起する

スライド 3: 今日のゴール（学習目標の提示）

- 緩和ケアは「終末期だけのもの」ではないとわかる
- あなたの職種でできる緩和ケアが1つ見つかる
- 困ったときに誰に相談すればいいかがわかる

「自分には関係ない」→「自分にもできることがある」
この変化が今日のゴールです。

☒ ガニエ第2事象：学習目標を知らせる

スライド 4: まず、誤解を解きましょう（前提条件の想起）

よくある誤解:

誤解	実際
---	---
終末期の人だけが受けるもの	診断されたときから始められる
がんの人だけが対象	心不全、認知症、呼吸器疾患なども対象
特別な専門家だけがやること	すべての職種が関われる
「もう何もできない」ということ	「できることはまだまだたくさんある」ということ

☒ ガニエ第3事象：前提条件を思い出させる

スライド 5: WHO の定義をやさしく

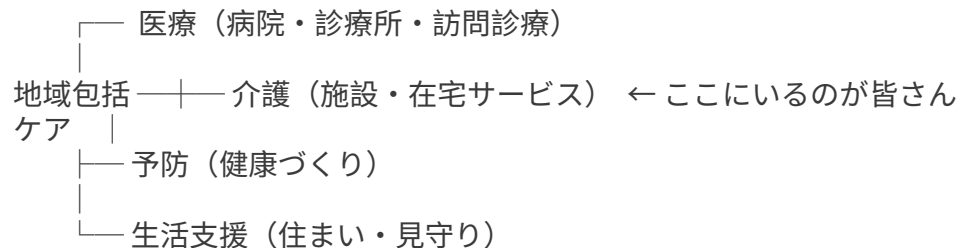
重い病気に向き合う患者さんご家族の
「つらさ」を和らげて
その人らしい生活を支えること

「つらさ」には 4 つの種類があります：

体のつらさ		痛み、息苦しさ、だるさ
心のつらさ		不安、悲しみ、怒り
人とのつながりのつらさ		孤独、家族との関係
生きる意味のつらさ		「何のために生きているのか」

体のつらさだけが緩和ケアではありません。

スライド 6: 地域包括ケアの中の緩和ケア

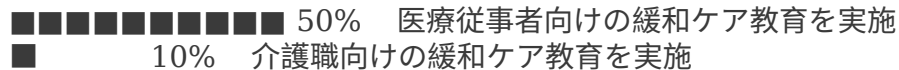


緩和ケアは、このすべてに横串を通すもの。

利用者さんの「つらさ」は、医療の場だけでなく、介護の場、生活の場で日々感じられている。

スライド 7: 衝撃のデータ

日本緩和医療学会の全国調査（528 施設）によると ...



** 介護職は、利用者さんと最も長い時間を過ごしているのに、

緩和ケアについて学ぶ機会が最も少ない。 **

1 日の接触時間（施設の場合）

介護職：8-16 時間

看護師：1-2 時間

医師：数分 - 数十分

→ 一番近くにいるあなたの「気づき」が、一番大切。

☒ ガニエ第 4 事象：新しい内容を提示する（データで実感を促す）

スライド 8: あなたの職種でできること

職種	あなたにできる緩和ケア
---	---
介護士	日常の変化に気づく。「いつもと違う」を伝える。声かけ、傾聴、安楽な姿勢の工夫
看護師	症状の評価、医師への報告、ケアプランへの反映、介護職の相談窓口
リハビリ職	「できること」を維持する支援、動作時の痛みの評価、リラクゼーション
事務職員	家族への丁寧な対応、環境整備、情報連携のサポート
栄養士	食べたいものを聞く、食べやすい形態の工夫、栄養より「楽しみ」
相談員	家族の不安への寄り添い、社会資源の紹介、意思決定の支援

「自分の仕事の延長線上」に緩和ケアはあります。

☒ ガニエ第5事象：学習の指針を与える

スライド 9: 具体的な場面で考えてみましょう

いつもの「おはようございます、よく眠れましたか？」

これだけで立派な緩和ケアのアセスメントです。

+ ひと言の例:

- 「体のどこか痛いところはありませんか？」
- 「何か気になっていることはありますか？」
- 「昨日のお薬は楽になりましたか？」

食事量が減ってきた利用者さんに:

- ☒ 「ちゃんと食べないと元気になれませんよ」
- ☒ 「食べたいものはありますか？ 少しでも好きなものを」

入浴を嫌がるようになった利用者さん:

- 痛みで動くのがつらい？
- 裸になることへの抵抗？
- 体力が落ちて疲れる？
- → 「嫌がる」の背景を考えること = 緩和ケア的思考

スライド 10: グループワーク（5 分間）

** 「あなたが関わった利用者さん（患者さん）で、
もっとこうできたらよかったな、と思ったことは？」 **

- 正解はありません
- 批判しない、聞くことに集中
- 「自分だったらどうする？」を考えてみる
- 個人情報に配慮（名前は出さない）

1 人 1 分ずつ話して、残り 1 分で「共通点」を見つけてください。

☒ ガニエ第 6 事象：練習の機会を与える

スライド 11: グループワークの共有

ファシリテーターが 2-3 グループに発表を依頼

ポイント:

- 「気づいていた」のに「何もできなかった」経験が多い
- → それは「知識がなかった」のではなく「伝え方を知らなかった」だけ
- 今日からその「伝え方」を一つずつ学んでいきましょう

☒ ガニエ第 7 事象: フィードバックを与える

スライド 12: 困ったときの相談先

あなたが「何かおかしい」と感じたら:

Step 1: まず看護師に伝える

「〇〇さん、いつもと違って△△な様子です」

Step 2: 看護師が判断して医師に報告

→ 必要に応じて緩和ケアチームに相談

Step 3: カンファレンスで情報共有

あなたの「気づき」がチーム全体のケアを変える

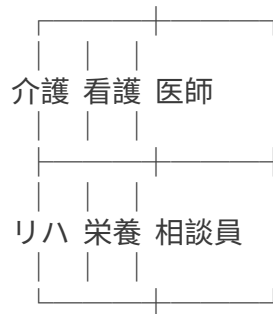
** 大切なのは「正確な医学的判断」ではなく、

「いつもと違う」と感じたことを伝えること。 **

連絡先	役割
---	---

スライド 13: 多職種で支えるということ

利用者さん・ご家族



事務・その他

全員の「気づき」が集まって、
はじめて「その人らしいケア」が実現する

** 介護職の「気づき」は、医師や看護師には見えないものを含んでいます。

スライド 14: まとめ

1. 緩和ケアは「終末期だけ」「がんだけ」のものではない
→ つらさを和らげること、すべてが緩和ケア
2. あなたの「いつもと違う」という気づきが出発点
→ 専門知識がなくても大丈夫。感じたことを伝えよう
3. 一人で抱えない。看護師に伝えることから始めよう
→ あなたの一言がチームのケアを変える

スライド 15: 小さな一歩から

今日のワーク：

明日から、利用者さんに一つだけ
いつもの声かけに「+ひと言」を加えてみてください。

例：「痛いところはありませんか？」

例：「何か気になることはありますか？」

例：「最近、眠れていますか？」

☒ ワークシート（配布）に書いてください：

- 「明日から試してみたい+ひと言」を1つ
- 1週間後に「やってみてどうだったか」を共有する時間を設けます

☒ ガニエ第8・9事象：学習の成果を評価する / 保持と転移を促進する

スライド 16: おわりに

目の前の人の「つらさ」に気づき、
寄り添い、伝える。
それは、皆さんが毎日していることの延長線上にあります。

ありがとうございました。

質問・感想があればいつでもお声がけください。

本スライドの出典：日本緩和医療学会全国調査 Palliative Care Research (J-STAGE), WHO 緩和ケアの定義 (2002 改訂)

作成：Learning Design Lab / AI Agent Team



AI × ■■■■ — ■■■■■■

2026-03-26 | ■■■ PPTX

AI 時代の臨床推論 — 使いこなす力と疑う力

対象：研修医・専攻医

時間：45 分

日付：2026-03-26

ID モデル：ガニエの 9 教授事象

ブルーム：理解 → 分析 → 評価 → 創造

Slide 1: 世界はもうこのフェーズにいる（0-3 分）

80% 超の医師が AI を臨床で活用している。
76% が AI で診療能力が向上したと実感。
— AMA 調査 / IME 2026（マイアミ大学, 2026 年 3 月）

しかし同時に——

AI を使った医師の診断精度は、AI 単独より低かった。
GPT-4 単独 : 90%
医師 + GPT-4: 76%
医師 単独 : 74%
— Frontiers in Digital Health, 2025

問い : AI は味方か、それとも新しい罠か？

Slide 2: 今日の学習目標（3-4 分）

この 45 分の後、あなたは：

- 説明できる — AI の 3 世代とマルチエージェントの基本概念（理解）
- 分析できる — AI が持つ認知バイアスの種類とメカニズム（分析）
- 判断できる — AI を使うべき場面と、使うと逆効果になる場面（評価）
- 提案できる — 自分の研修に AI をどう組み込むかの具体策（創造）

Slide 3: 前提確認 — あなたと AI の関係（4-6 分）

- AI（ChatGPT や Claude など）を臨床で使ったことがある人？
- 使ったとき、AI の答えに引きずられた経験がある人？
- 逆に「AI は間違っている」と確信して無視した経験がある人？

どちらの反応も認知バイアスの一種です。
今日はこの「引きずられる力」と「疑う力」の両方を扱います。

Slide 4: AI の進化全体像 — 3 世代からマルチエージェントへ (6-10 分)

世代	特徴	医療での例
-----	-----	-----
第 1 世代: ルールベース	人間がルールを書く	処方チェックシステム
第 2 世代: 生成 AI	1 つの AI が何でもやる	ChatGPT に症例を聞く
第 3 世代: エージェント AI	専門 AI チームが協力	複数 AI が分担して診断支援

[Supervisor Agent] (総合医)

- └── [Agent A] (検査データ専門)
- └── [Agent B] (画像診断専門)
- └── [Agent C] (薬剤相互作用専門)
- └── [Agent D] (ガイドライン照合専門)

発見	内容
-----	-----
精度向上	マルチエージェントが単一 AI を統計的に有意に上回る

Slide 5: 臨床実装の最前線 — BJC Healthcare の事例 (10-12 分)

項目	内容
-----	-----
機関	BJC Healthcare ACO
データ	35,000 人超の患者データで訓練
機能	高リスク患者の自動選定 + 終末期ケア計画ワークフロー
学習方式	教師あり学習 + 臨床医フィードバックによる強化学習
特徴	デプロイ後も継続的に学習

human-in-the-loop	human-on-the-loop
-----	-----
AI が提案 → 人間が毎回承認	AI が自律実行 → 人間が監督
安全だが遅い	速いが信頼性の設計が重要
現在の多くの医療 AI	BJC 等の先進事例

「人間がすべてチェックしなくてもいい AI」は、医療でどこまで許されるか？

Slide 6: しかし AI にはバイアスがある (12-16 分)

1. アンカリングバイアス

最初に得た情報に固執し、後の情報を過小評価する

- 例: 「胸痛の 30 歳男性」→ 筋骨格系と決めつけ → 心筋炎を見逃す

2. プレマチュアクロージャー (早期閉鎖)

十分な情報収集前に診断を確定してしまう

- 例: 発熱 + 咳 → 「風邪でしょう」→ 肺炎を見逃す

3. 利用可能性ヒューリスティクス

最近経験した症例に引きずられる

- 例: 先週コロナ患者を 10 人診た → 今日の発熱患者もコロナだろう

共通点: ワーキングメモリの制約 (同時に 4-5 項目しか処理できない) が根本原因

Slide 7: 新発見 — AI そのものがバイアスを「増幅」する (16-19 分)

バイアスの種類	人間	LLM	意味
-----	-----	-----	-----
不作為バイアス	あり	人間より強い	「何もしない」を過度に推奨する
フレーミング効果	あり	顕著	問いの立て方で答えが変わる
アンカリング	あり	確認済み	最初の情報に引きずられる

- 終末期ケア：AI が「積極的治療介入しない」を過度に推奨する可能性
- 救急判断：問診の聞き方（フレーミング）で AI の推奨が変わる
- 鑑別診断：最初に提示した仮説に AI が引きずられる（アンカリング）

AI を「答え合わせ」に使うと、自分の仮説を AI に確認させるだけになる。
→ 医師のアンカリング + AI のアンカリング = バイアスの二重増幅

Slide 8: 「使いこなす力」 — AI の 3 つの正しい使い方 (19-22 分)

「この症例で見落としている鑑別は？」と構造化を促す

- バイアス対策： プレマチュアクロージャーの防止

「なぜその診断だと思いますか？ 他の可能性は？」と問いを立てる

- バイアス対策： アンカリングの自覚を促す

「あなたの診断が間違っているとしたら、最も危険な見逃しは？」と反論する

- バイアス対策： 利用可能性ヒューリスティクスの打破

キーインサイト： AI は「答えを出す道具」ではなく「問いを立てる鏡」として使うと効果的。
PNAS 研究を踏まえると、AI に「判断」を委ねるのではなく「思考の拡張」に使うことが重要。

Slide 9: ハンズオン体験（22-28 分）

症例：45 歳女性、2 週間前からの倦怠感と微熱

手順：

- A さん（2 分）：ChatGPT/Claude に「患者役」をさせて問診する
- B さん（2 分）：AI を「ソクラテスのガイド」として使い、自分の鑑別診断を検証する
- 比較（2 分）：体験を比較 — どちらが「考えさせられた」か？

プロンプト例（患者役）：

あなたは 45 歳女性の患者です。2 週間前からの倦怠感と微熱で受診しました。医学生の間診練習に協力してください。質問されるまで情報を出さないでください。

プロンプト例（ソクラテスのガイド）：

私は研修医です。45 歳女性、倦怠感と微熱の患者を診ています。私の鑑別診断に対して、見落とししている可能性をソクラテス的に問いかけてください。答えは教えないでください。

Slide 10: 「疑う力」 — AI 仮想患者の構造的限界（28-31分）

	機能的忠実度（臨床精度）	会話的忠実度（人間らしさ）
---	---	---
評価	高い	低い
意味	症状・検査値は正しい	自然な間、感情表現が不自然
多疾患対応	苦手	さらに低下

Stage 1
安定・恒常性

→

Stage 2
創発・適応

→

Stage 3
カオス

→

Stage 4
不連続的変容

予測可能
ルールベース

パターンが
動的に変化

予測不能
非線形

根本的な
パラダイム転換

	Stage 1（安定）	Stage 2（創発）
---	---	---

Slide 11: 統合・使い分けマトリクス（31-34 分）

場面	AI の役割	推奨度	根拠
-----	-----	-----	-----
OSCE 事前練習（単一疾患）	模擬患者の代替	推奨	Stage 1、機能的忠実度が高い
鑑別診断の網羅性チェック	Red Team Partner	推奨	バイアス打破に有効
EBM 文献の構造化要約	Framework Coach	推奨	情報の構造化は AI の得意領域
複雑症例の臨床判断	答え合わせ	非推奨	バイアスの二重増幅リスク
多疾患患者のシミュレーション	模擬患者	時期尚早	会話的忠実度の限界
患者への共感的対応の練習	模擬患者	不十分	Stage 2 以降、人間の指導が不可欠
終末期ケアの意思決定支援	判断支援	要注意	不作為バイアスのリスク (PNAS)

原則 1（使いこなす力）：Stage 1 の課題には AI を積極的に活用する。3 つの役割（Coach/Guide/Red Team）で使う。

原則 2（疑う力）：Stage 2 以降の課題では、AI の出力を批判的に読む。特に「何もしない」という推奨には要警戒。

Slide 12: ディスカッション（34-40 分）

問い（1つ選んでください）：

- 体験の振り返り：ハンズオンで「患者役 AI」「ソクラテス的ガイド AI」「Red Team AI」のうち、どれが最も学びになりましたか？なぜ？
- PNAS 研究の臨床的含意：AI が「何もしない」を過度に推奨する（不作為バイアス）ことは、あなたの臨床でどんな場面で問題になりそうですか？
- 未来の研修像：80% 超の医師が AI を使う時代に、研修医教育はどう変わるべきですか？「AI リテラシー」は OSCE に入れるべき？

Slide 13: 振り返りとアクション（40-45 分）

1. 世界は「使うかどうか」から「どう教育に組み込むか」へ

- 80% 超の医師が AI 活用（IME 2026）
- マルチエージェント AI が臨床実装段階（Mount Sinai, BJC Healthcare）

2. AI は答えを出す道具ではなく、問いを立てる鏡

- 受動的に使うとバイアスを二重増幅する（Frontiers + PNAS）
- 3つの役割（Coach/Guide/Red Team）で能動的に使う

3. AI の限界を知ることが、これからの医師の必須能力

- 不作為バイアス、フレーミング効果は AI にも存在する（PNAS 2026）
- 機能的忠実度は高いが、会話的忠実度は低い（JMIR 2026）
- Stage 2 以降の複雑さは、現在の AI の限界の先にある

- [] 明日の外来で、AI に「ソクラテスのガイド」として 1 回聞いてみる
- [] 同僚と「AI を使って失敗した体験」を 1 つ共有する
- [] Mount Sinai 論文または PNAS 論文の Abstract を 1 本読む
- [] 自分の業務で「AI に任せたい業務」と「AI に任せたくない業務」を書き出す

Slide 14: 参考文献

- Mount Sinai (2026) — Orchestrated Multi-Agent AI Systems Outperform Single Agents in Health Care. npj Health Systems.
- Frontiers in Digital Health (2025) — Transforming Clinical Reasoning: The Role of AI in Supporting Human Cognitive Limitations.
- PNAS (2026) — LLMs Amplify Cognitive Biases in Moral Decision-Making.
- JMIR Formative Research (2026/3) — Scaling Multimodal Agentic AI in Medical Education: Multisite Cross-Sectional Study.
- JMIR Medical Informatics (2026) — LLM-Based Virtual Patient Systems: Comprehensive Systematic Review.
- npj Digital Medicine (2026) — Anchoring Bias in Clinical LLMs.
- IME 2026 — Innovations in Medical Education Conference, University of Miami.
- AMA — Boost Health AI Training Across Medical Education Continuum.
- HIMSS26 — Multi-AI Agents for Clinical Decision Support (BJC Healthcare).

Generated by Scribe Agent | Learning Design Lab | 2026-03-26

Integrated from: 2026-03-21 Multi-Agent AI, 2026-03-25 AI Clinical Reasoning, 2026-03-26 Briefing



AI × ■■■■ — ■■■■■■■■

2026-03-26 | ■■■■ PPTX

AI 時代の医療者に求められること

対象：全スタッフ（看護師・介護士・事務職員を含む）

時間：15 分

日付：2026-03-26

ID モデル：ガニエの 9 教授事象

ブルーム：理解 → 適用 → 評価

スライド 1: 知っていますか? この数字 (0-2 分)

「病院で AI を使っている医師が、80% を超えました。」
— AMA (アメリカ医師会) 2026 年調査より

- 2023 年には約 40% だったのが、たった 3 年で 2 倍に
- そのうち 76% 以上が「AI のおかげで診療の質が上がった」と回答

「AI はもう "未来の話" ではなく、"今の話" です。
でも、AI って本当にすごいのか? 怖くないのか?
今日の 15 分で、一緒に考えましょう。」

この 15 分の後、あなたは:

- AI の得意なこと・苦手なことがわかる
- AI が間違える理由をイメージできる
- 自分の仕事で AI とどう付き合うか考えられる

スライド 2: AI の「得意」と「苦手」 （2-5 分）

AI の得意技	身近な例え
-----	-----
大量のデータを素早く処理	何万冊の本を一瞬で検索できる図書館司書
パターンを見つける	「この検査値の組み合わせは要注意」と気づく
24 時間休まず働く	夜勤も疲れも関係なし
同じ作業を正確に繰り返す	書類の転記やデータ入力のプロ

AI の苦手	なぜ苦手?
-----	-----
人の気持ちを理解する	「不安そうな表情」「声のトーン」は数字にできない
文脈を読む	「この患者さんは家族との関係が複雑で ... 」が伝わらない
責任を取る	判断の最終責任は必ず人間にある
「なんとなくおかしい」に気づく	ベテランの直感や経験は数値化できない

たとえばなら：

AI は「ものすごく優秀だけど、空気が読めない新人スタッフ」。
データの処理は速いけど、患者さんの涙の意味はわからない。

スライド 3: AI も「間違える」 — 知っておいてほしい話（5-8分）

最新の研究（PNAS 2026 年発表）で、AI の「くせ」がわかってきました：

例えば：

「廊下で患者さんが転びそうになっている。

手を出して支えたら → もしケガさせたら自分のせい？

何もしなかったら → たまたま転んだだけ？」

AI は「何もしない方が安全」と判断しがちです。

でも医療では、「何もしないこと」も判断であり、責任がある。

最初に見た数字に影響されて、後から入った情報を軽視してしまう。

人間にもある「くせ」ですが、AI はこれをさらに強めてしまうことがある。

「成功率 90% の手術です」と聞くと安心するけど、

「10 人に 1 人は失敗します」と聞くと不安になる。

同じことなのに、伝え方で印象が変わる — AI にもこの傾向がある。

AI の答えを「そのまま信じる」のではなく、「本当かな？」と立ち止まる。

これが、AI 時代に一番大切なスキルです。

スライド 4: 実際の医療現場ではどう使われている? (8-9分)

BJC Healthcare という病院グループでは:

- 35,000 人以上の患者データをもとに
- AI が「この患者さんは今後のケア計画について話し合うタイミングかもしれません」と提案
- 最終判断は必ず医師やケアチームが行う

ポイント : AI は「提案する」だけ。「決める」のは人間。

これまで	これから
-----	-----
スタッフだけでカンファレンス	AI が事前に情報を整理してくれる
手作業でデータを集計	AI が自動で傾向をまとめてくれる
経験と勘で優先度を判断	AI が「見落とし」を減らす手伝い

AI はチームの一員。でも、リーダーは常に人間です。

スライド 5: みんなで考えよう (9-13 分)

3-4 人のグループで話し合ってみましょう:

テーマ:

「あなたの業務の中で ...」

1. AI に手伝ってもらいたいことは?
2. 絶対に人がやるべきことは?

考えるヒント:

- 毎日繰り返しているデータ入力や記録作業は?
- 「ダブルチェック」で時間がかかっている業務は?
- 患者さんやご家族と直接向き合う場面は?
- 「この仕事、間違えたら大変」という判断業務は?

考え方のコツ:

「AI に任せて楽になること」と「人間だからこそ意味があること」を分けてみよう。

- 各グループから 1 つずつ共有

スライド 6: まとめ — だから、あなたが大切（13-15 分）

	ポイント	ひとことで
---	-----	-----
1	AI は便利だけど万能じゃない	得意なことと苦手なことがある
2	AI も間違える・偏る	「本当かな? 」と立ち止まる習慣が大切
3	人間にしかできないことがある	患者さんに寄り添えるのはあなただけ

テクノロジーは変わります。
でも、患者さんの手を握れるのは、あなただけです。
AI が得意なことは AI に任せて、
あなたにしかできないこと — 笑顔、声かけ、気づき、寄り添い —
に、もっと時間を使えるようになる。
それが「AI と一緒に働く未来」です。

「今日聞いた話の中で、1 つだけ誰かに伝えるとしたら、何を選びますか? 」

- 日常業務の中で「これ、AI に手伝ってもらえないかな? 」とアンテナを立ててみる
- AI の答えに接したとき「本当かな? 」と一度立ち止まってみる
- わからないことがあれば、いつでも相談してください

参考文献

- AMA (2026) — 医師の AI 活用調査（80% 超が臨床で AI 活用）。IME 2026 Conference, University of Miami Miller School of Medicine. <https://news.med.miami.edu/innovations-in-medical-education-2026-explores-the-power-of-ai/>
- AMA (2026) — Boost health AI training across medical education continuum. <https://www.ama-assn.org/practice-management/digital-health/boost-health-ai-training-across-medical-education-continuum>
- Healthcare IT News (2026) — BJC Healthcare ACO, マルチ AI エージェントによる臨床意思決定支援（HIMSS26 発表）。<https://www.healthcareitnews.com/news/how-multi-ai-agents-can-improve-clinical-decision-support>
- PNAS (2026) — LLM の認知バイアス増幅に関する研究（不作為バイアス・フレーミング効果）。<https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2412015122>

ファシリテーター向けメモ

- [] プロジェクター or モニター
- [] タイマー（グループワーク 3 分計測用）
- [] 付箋（グループワーク用、任意）

- スライド 1: 「80%」の数字を最初に見せてインパクトを与える。「自分も AI 使ったことある? 」と問いかけて参加感を出す
 - スライド 2: 「空気が読めない新人スタッフ」の例えは笑いを誘いやすい。場が和んだところで「でも仕事は速い」と続ける
 - スライド 3: バイアスの話は難しくなりがちなので、必ず例え話で説明する。「転びそうな患者さん」の例は全職種がイメージしやすい
 - スライド 4: 「AI は提案、人間が決定」を繰り返し強調する
 - スライド 5: グループワークでは「正解はない」ことを最初に伝える。迷うこと自体が学び
 - スライド 6: 最後のメッセージは落ち着いたトーンで。「あなたが大切」を心を込めて
-
- 3/21 版: 「AI エージェント」の概念紹介が中心（AI チームの比喻）
 - 今回: 「最新データで見る AI の光と影」がテーマ。AI の限界やバイアスにも踏み込んだ内容
 - 両方受けた方には: 「前は "AI って何ができるか"、今回は "AI とどう付き合うか" 」と伝える



AI ■■■ — Clinical Reasoning with AI

2026-03-25 | ■■■ PPTX

AI は診断を助けるか？

臨床推論の認知バイアスと
AI 仮想患者の可能性と限界

研修医・専攻医向け勉強会 | 30 分 | 2026-03-25

Learning Design Lab

AI を使ったら、診断の正解率が下がった。

90%

GPT-4 単独

76%

医師 + GPT-4 補助

74%

医師 単独

— Frontiers in Digital Health, 2025

なぜ、AI を「使える」のに、
医師の精度はわずか 2% しか改善しなかったのか？

今日の学習目標

この 30 分の後、あなたは：

1 説明できる

臨床推論における 3 大認知バイアス
(アンカリング・プレマチュアクロージャール・利用可能性 H)

2 批判的に吟味できる

AI 仮想患者の「機能的忠実度」と
「会話的忠実度」の違い

3 判断できる

AI を使うべき場面と、
使うと逆効果になる場面

4 提案できる

自分の研修に AI をどう組み込むかの
アイデア

前提確認 — あなたの認知バイアス体験

Quick Poll (挙手)

☐ AI (ChatGPT など) を臨床で使ったことがある人?

☒ 使ったとき、AI の答えに引きずられた経験がある人?

☒ 逆に「AI は間違っている」と思って無視した経験がある人?

どちらも「認知バイアス」の一種です

臨床推論の 3 大認知バイアス

1. アンカリングバイアス

最初に得た情報に固執し、後の情報を過小評価する

例：「胸痛の 30 歳男性」→ 筋骨格系と決めつけ → 心筋炎を見逃す

2. プレマチュアクロージャージャー

十分な情報収集前に診断を確定してしまう

例：発熱 + 咳 → 「風邪でしょう」 → 肺炎を見逃す

3. 利用可能性ヒューリスティクス

最近経験した症例に引きずられる

例：先週コロナ 10 人 → 今日の発熱もコロナだろう

共通点：ワーキングメモリの制約（同時に 4-5 項目しか処理できない）が根本原因

AI はこれを「解決」できるか？

人間の限界	AI の特性
WM 4-5 項目	数千のデータを同時処理
最近の経験に引きずられる	訓練データ全体を均等に参照
疲労で精度低下	24 時間一定の精度
1 つの仮説に固執	複数仮説を並列評価

しかし現実には ...

AI を「答え合わせ」に使うと、自分の仮説を AI に確認させるだけになる

→ アンカリングバイアスを増強してしまう

AIの「正しい使い方」—— 3つの役割

1 Framework Coach (枠組みコーチ)
「この症例で見落としている鑑別は？」
と構造化を促す

2 Socratic Guide (ソクラテス的ガイド)
「なぜその診断だと思いますか？ 他の可能性は？」
と問いを立てる

3 Red Team Partner (レッドチーム)
「あなたの診断が間違っているとしたら、
最も危険な見逃しは？」と反論する

AIは「答えを出す道具」ではなく「問いを立てる鏡」として使うと効果的

ハンズオン体験（5分）

ペアワーク：AIに問診させてみよう

症例：45歳女性、2週間前からの倦怠感と微熱

1. Aさん：ChatGPT/Claudeに「患者役」をさせて問診（2分）
2. Bさん：AIに「ソクラテス的ガイド」として鑑別診断を検証（2分）
3. 体験を比較：どちらが「考えさせられた」か？（1分）

プロンプト例（患者役）

あなたは45歳女性の患者です。
2週間前からの倦怠感と微熱で
受診しました。医学生の間診練習に
協力してください。質問されるまで
情報を出さないでください。

プロンプト例（ソクラテス的ガイド）

私は研修医です。45歳女性、倦怠感
と微熱の患者を診ています。私の鑑別
診断に対して、見落としている可能性
をソクラテス的に問いかけてください。
答えは教えないでください。

AI 仮想患者のエビデンス — 何が分かっているか

	多施設横断研究 (JMIR 2026/3)	システマティックレビュー (JMIR 2026)
研究数	1（多施設）	39 本の統合
対象	英国 GP・医学生	国際的
機能的忠実度 （臨床精度）	高い ☒	高い ☒
会話的忠実度 （人間らしさ）	低い ⚠	低い ⚠
多疾患対応	未検証	苦手 ☒

2 つの独立した研究が同じ結論 → 現在の LLM 技術の構造的限界

機能的忠実度：臨床シナリオの正確さ（症状・検査値が医学的に正しいか）

会話的忠実度：人間の会話らしさ（自然な間、感情表現、非言語的要素）

なぜ「会話的忠実度」が低いのか？

Aziz (2026) の Systems & Complexity Lifecycle で理解する



Stage 1（安定）→ AI が得意

単一疾患の問診
ルールベースで再現可能
→ 機能的忠実度 高い

Stage 2 以降（創発）→ AI が苦手

多疾患 + 心理社会的文脈
創発的対話・関係性が必要
→ 会話的忠実度 低い

家庭医の日常は Stage 2 以降 → 最も必要なシミュレーションが AI の最も苦手な領域

臨床への実装 — 使い分けマトリクス

場面	AI の役割	推奨度
OSCE 事前練習（単一疾患）	模擬患者の代替	☑ 推奨
鑑別診断の網羅性チェック	レッドチームパートナー	☑ 推奨
EBM 文献の構造化要約	Framework Coach	☑ 推奨
複雑症例の臨床判断	答え合わせ	☒ 非推奨
多疾患患者のシミュレーション	模擬患者	⚠ 時期尚早
患者への共感的対応の練習	模擬患者	⚠ 不十分

Stage 1 の課題には AI を積極的に使う | Stage 2 以降の課題には人間の指導が不可欠

ディスカッション（5分）

3人グループで3分 → 全体共有2分

問い 1

「患者役 AI」と「ソクラテスのガイド AI」
のどちらが学びになりましたか？ なぜ？

問い 2

あなたの研修の中で、AIを「レッドチーム
パートナー」として使えそうな場面はどこですか？

問い 3

「機能的忠実度は高いが会話的忠実度は低い」
——患者さんへのAI活用でも同じことが言えそうですか？

持ち帰り

1 AI は答えを出す道具ではなく、問いを立てる鏡

受動的に使うとバイアスを増強する。能動的に使うと思考を拡張する。

2 「機能」と「会話」は別物

AI は臨床的に正確だが人間的ではない。Stage 1/2 の構造的違いで説明できる。

3 家庭医が扱う複雑さは、現在の AI の限界の先にある

だからこそ、限界を知った上で使いこなす力がこれからの医師に必要。

明日の外来で AI に 1 回聞いてみてください

「この患者の鑑別で私が見落としている可能性は？」と AI に聞いてみる。
来週、その体験をシェアしましょう。



■ ■ AI ■ ■ ■ — ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

2026-03-24 | ■ ■ ■ PPTX

医療 AI の実態 2026

光と影を踏まえて、使いこなすために

Doximity（米国医師向けプラットフォーム）8万人 + AMA（米国医師会）1,300人 調査から読む

研修医・専攻医向け 30分 | 2026-03-24

数字が語る現実

94%

医師が AI 利用中
または検討中

Doximity 2026

81%

AI 利用率
(2023 年 38% から倍
増)

AMA 2025

2 時間

1 日あたりの
時短効果

アンビエント AI

#1

家庭医が
AI 最頻度ユーザー

Doximity 2026

「AI は使えるのか？」のフェーズは終わった。問題は「どう安全に使うか」。

医師は何に AI を使っているのか

用途	割合	具体例
臨床ドキュメント作成	最多	Nuance DAX, Abridge, Suki
「パジャマタイム」解消	主目的	勤務外の事務作業を削減
診断支援	少ない	OpenEvidence 等
患者対応・ケア	非常に少ない	今後の拡大領域

「パジャマタイム」 = 勤務後にパジャマでカルテを書く時間。
AI が解消してくれるのは、「診断」ではなく「事務」。

光の側

OpenEvidence

日 100 万件

査読済み文献ベースの
臨床意思決定支援

AI 研修 RCT

保持率 91%

AI が研修医教育の
質を向上させる

Mount Sinai

コスト 65 分の

マルチエージェント AI が
1
単独より優秀

影の側

ECRI 患者安全

AI 診断が #1

ECRI = Emergency Care
Research
Institute (米国医療安全研究機構)
自動化バイアスが誤診リスクを増大

スタンフォード

半数が試験で評価

実患者データは
わずか 5%

AMA 倫理

監視の空洞

AMA = American Medical
Association
(米国医師会)
倫理ジャーナル廃刊 x AI センター設
立

国家レベルの応答

NAM = National Academy of Medicine (米国医学アカデミー)

「AI時代の患者安全」イニシアチブ -- 2026年3月発足

Mayo Clinic CEO らが共同議長

「To Err Is Human」(2000年の画期的報告書)の遺産を継承
AIを活用した「ゼロハーム」国家戦略を策定中

ECRI (米国医療安全研究機構) が「警告」を出し、NAM が「戦略」を立てる。
「光と影」のその先に、「制度設計」が始まっている。

安全に使うための 4 ステップ

フレームワーク「知る→疑う→補完→伝える」

(1) 知る

この AI は何で
評価された？

(2) 疑う

自分の判断と
照合する

(3) 補完

AI+ 人間の
強みを組み合わせ

(4) 伝える

患者に
透明性を保つ

[!] AI の答えを鵜呑みにしない。常に自分の臨床判断と照合する。

倫理の空洞 -- 誰が監視するのか

- AMA = American Medical Association（米国医師会）が倫理ジャーナルを廃刊
- 同時に AI センターを設立 -- 「倫理」より「実装」を優先する姿勢
- IC = Informed Consent（インフォームドコンセント：説明と同意）に AI 使用を含めるべきか未定
- VC = Venture Capital（ベンチャーキャピタル：投資ファンド）が医療 AI 市場に大量資金投入
- 「誰のための AI か」が問われている -- 患者か、効率化か、投資家か

テクノロジーの進歩に、倫理的議論が追いついていない。
だからこそ、現場の医師が考える必要がある。

ディスカッション

4 分間 → 全体共有 2 分

あなたが AI を使って「助かった」経験と
「危なかった」経験は？
その違いは何だったか？

考えるヒント

- AI の答えをそのまま使ったことはあるか？
- 患者に AI 使用を伝えたことはあるか？
- AI の間違いに気づいた経験はあるか？

持ち帰り

来週までの 1 アクション

- 自分が使っている（または使おうとしている）AIの「評価方法」を調べる
- 同僚と「AIの答えが自分の判断と違った経験」を共有
- 「パジャマタイム」がどれくらいあるか、自分で計測してみる

医師の 94% が使っているのに、
「どう安全に使うか」を議論している人はほとんどいない。

それを議論できるあなたは、もう一歩先にいる。



■ ■ AI ■ ■ ■ — ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

2026-03-24 | ■ ■ ■ ■ PPTX

医療 AI の「今」を知る

私たちの働き方はどう変わるのか

全スタッフ向け 15 分 | 2026-03-24

AI は今、医療でどう使われているか

94%

の医師が
AI を利用中・検討中

Doximity
(米国医師向けプラットフォーム)

81%

の AI 利用率
(2 年前は 38%)

AMA
(米国医師会)

2 時間 +

の時間短縮
1 日あたり

音声 AI
カルテ記録

AI は「特別なもの」から「日常のツール」になりつつある

AI が担っていること・まだ担えないこと

領域	AI の役割	私たちへの影響
カルテ記録	医師の音声を自動で文書化	記録業務の負担減
事務作業	書類作成・要約を支援	残業時間の短縮
診断支援	情報提示（最終判断は医師）	判断の参考として活用
患者対応	まだ発展途上	人間にしかできない領域

[!] AI は「医師の代わり」ではなく「医療チームの支援ツール」

AI の光と影

【+】 光の側

- カルテ記録時間が大幅に短縮
- 医師の燃え尽き症候群の軽減
- 研修医教育の質が向上（保持率 91%）
- 膨大な文献を瞬時に検索・要約

【!】 影の側

- AI の誤りを見逃すリスク
- 実際の患者データでの検証が不十分
- 個人情報保護の課題
- 「AI に任せきり」の危険性

大切なのは「光」だけでも「影」だけでもなく、両方を知ること

私たちにできること

知る

AI が何をしているか
理解する

確認する

AI の結果を
鵜呑みにしない

伝える

患者さんに
正直に説明する

学び続ける

新しい技術に
関心を持ち続ける

AI は「使う側」の姿勢で結果が変わる

よくある質問

質問	回答
AI に仕事を奪われる？	現時点では「代替」ではなく「支援」。事務作業の負担軽減が中心
患者の情報は大丈夫？	個人情報保護は最重要課題。施設のルールに従うことが大切
私も使うべき？	まずは「何ができるか」を知ることから。無理に使う必要はない
間違えたら誰の責任？	最終判断は医療者。AI は参考情報の提供者

今日の持ち帰り

- 医療 AI は急速に広がっている -- 医師の 94% が利用中・検討中
- 主な用途は「カルテ記録」と「事務作業」の効率化
- 光（時短・質の向上）と影（誤りのリスク・倫理課題）の両面がある
- 大切なのは「知る・確認する・伝える・学び続ける」の 4 つ

AI は「怖いもの」でも「魔法」でもない。
正しく知って、賢く付き合っていくための第一歩。



■■■ = ■■■■■■■■■■A■■■■■ x ■■■■■■■■■■

2026-03-24 | ■■■■ PPTX

Orchestrator

オーケストレーターとしての家庭医

AI 研究が証明した「統合者」の価値

Google/MIT マルチエージェント研究 x 家庭医療のエビデンス

2026-03-24

AI が証明したこと

Google / MIT / DeepMind 共同研究 (2025-2026)
単一 AI のエラー率を「1」としたとき、専門 AI を増やすと...

統合者なし (Bag of Agents)

エラー 17 倍に増
幅

専門家が個別に動くと
矛盾・重複・欠落が雪だるま式

統合者あり (Orchestrated)

エラー 4 倍に抑制

統合者が全体を調整すると
エラーの増幅を約 75% 抑制

「専門家の数」より「調整の構造」が重要。
これは、まさに医療の話だ。

AI の発見 = 医療の現実

AI マルチエージェント	日本の医療
専門 AI がバラバラに動く (「Bag of Agents」)	専門医がバラバラに診る (ポリドクタリング)
オーケストレーター AI が 全体を統合	家庭医がオーケストレーター として統合
エラー 17 倍 → 4 倍に抑制	ポリファーマシー 2.18 倍 → 抑制
コスト 80% 削減	外来費用約 2 倍 → 抑制

1975 年、日野原重明が「プライマリケアのニードはきわめて高い」と意見具申。
2004 年、岩崎榄が「分化ばかり進んで統合がなおざり」と指摘。
2009 年、Hutt が「患者のオーケストラの指揮者がいない」と論考。
→ 50 年間の警告が、2026 年の AI 研究で科学的に裏付けられた。

日本の現実 — 数字が語る断片化

0.3%

全医師に対する
家庭医の割合

1,126 人 / 339,623 人
(2022 年)

65.3%

高齢者の
ポリドクタリング率

複数施設を定期受診
(平均併存疾患 4.7)

2.18 倍

ポリファーマシー
のリスク

3 施設以上受診時
(OR 2.18)

2 倍

外来医療費の
増加

3 施設以上受診時
vs 1 施設

出典 : PMC (2023), BMC Health Services Research (2020), Scientific Reports (2025)

スターフィールドのエビデンス

Barbara Starfield (Johns Hopkins, 2005) — プライマリケアの定量的証明

プライマリケア医
1人/万人 ↑

死亡率 5.3%↓

年間 49 人 /10 万人の
命が救われる

プライマリケア
スコア 5 点 ↑

心疾患早死
最大 15%↓

営気管炎による
早死も 6.5%↓

米国での試算

年間 12.8 万人
の死亡を予防可能

プライマリケアを
充実させることで

出典 : Milbank Quarterly (2005), Macinko et al. (2007) — PMC2690145

世界の「オーケストレーター」モデル

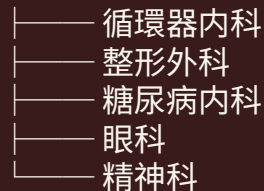
国	家庭医の役割	仕組み	成果
英国	ゲートキーパー + QOF(質評価)	NHS における GP システム	不利な地域の受診率向上
オランダ	ゲートキーパー (専門医には紹介必須)	包括払い制度 糖尿病・ COPD 管理	糖尿病の質指標改善
デンマーク	ゲートキーパー + グループ診療	OECD 最高評価の PC	予防可能な入院率低下
オーストラリア	GP がゲートキーパー + チームベース	Medicare のかかりつけ医 (GP) 登録制	慢性疾患管理の 国際的成功例
米国	FM/IM が PCP として機能 保険種で GK の有無が変わる	HMO: 紹介必要 PPO: 自由受診可能	PCP 不足が深刻 PC 弱い地域で死亡率 ↑
日本	フリーアクセス	患者が自由に	ポリドクターリング 65%

ゲートキーパー = AI の「オーケストレーター検証ゲート」。
家庭医を通さないと専門医に行けない仕組みが、
構造的に不要な受診を抑制し、ケアの質を上げる。

なぜ「統合者」が必要なのか

断片化したケア

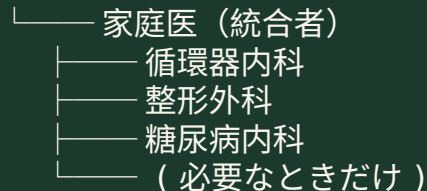
患者



→ 誰が全体を見る？

統合されたケア

患者



→ 全体を見る人がいる

AI も医療も同じ結論：「専門家の数」ではなく「調整の構造」が質を決める

スターフィールドの 4 つの柱

強いプライマリケア = この 4 つが揃っている

First Contact 最初の窓口

患者が最初に相談する
場所がある

Continuity 継続性

同じ医師が長期的に
一人の患者を診る

Comprehensiveness 包括性

幅広い問題に
対応できる

Coordination 調整機能

専門医との連携を
統合する

AI のオーケストレーター = 「Coordination」の役割。家庭医 = 4 つ全てを担う「システムの専門医」

ディスカッション

4 分間 → 全体共有 3 分

あなたの現場で、「オーケストレーターがいないせいで起きている問題」は何か？
それを解決するには何が必要？

考えるヒント

- ポリドクタリングで困った患者さんの経験は？
- 「全体を見る人」がいたら何が変わる？
- 日本のフリーアクセス制度をどう思う？

家庭医は「システムの専門医」である

専門医	家庭医
臓器の専門家	「人」の専門家
深く狭く	広くつなぐ
各パーツを最適化	システム全体を最適化
AI の専門エージェント	AI のオーケストレーター

Google/MIT が証明したこと：
「専門家の数」より「統合の質」が成果を決める。

家庭医は、「何でも診る医師」ではない。
「全体を見て、つないで、守る」システムの専門家だ。



CBE/EPA ■■ — ■■■■■■■■■■■■■■■■

2026-03-24 | ■■■ PPTX

CBE / EPA

Competency-Based Education / Entrustable Professional Activity

コンピテンシー基盤型教育と EPA -- 「点数」から「できること」へ

指導医・プログラムディレクター向け | 30 分 | 2026-03-24

導入の問い

USMLE（米国医師国家試験）で高得点の研修医が、
必ずしも「良い医師」になるとは限らない。
-- では、何で評価すればいいのか？

この 30 分の後、あなたは：

- CBE = Competency-Based Education（コンピテンシー基盤型教育）の基本概念を説明できる
- EPA = Entrustable Professional Activity（任せられる専門的活動）とマイルストーン評価を理解できる
- 自分の指導・研修に CBE の要素を 1 つ取り入れる計画を立てられる

試験の点数は何を予測するのか？

指標	事実	意味
USMLE Step 1 高得点	レジデントの臨床 パフォーマンスを予測しない	知識 ≠ 能力
クラークシップ 「優秀」評価	施設間で 5% ～ 67% のばらつき	基準が曖昧
筆記試験	「知っている」を測るが 「できる」を測らない	評価方法の不整合

「試験に受かる力」と「患者を診る力」は別物。
このギャップを埋めるのが CBE。

CBE（コンピテンシー基盤型教育）とは何か

	従来の教育	CBE
評価基準	時間（何年間研修したか）	能力（何ができるようになったか）
測定方法	筆記試験・口頭試験	EPA（実際の信頼レベル） + マイルストーン
指導者の役割	試験官・評価者	コーチ・伴走者
ゴール	合格ラインを越える	一人前の医師として任せられる

CBE = 「何年研修したか」ではなく「何ができるようになったか」で評価する仕組み

EPA -- 「任せられる」を段階的に評価する

EPA = Entrustable Professional Activity (任せられる専門的活動)

Level 1	観察のみ	見学している段階
----------------	-------------	----------

Level 2	直接指導下	指導医が横で見ている
----------------	--------------	------------

Level 3	間接指導下	一人でやって後で確認
----------------	--------------	------------

Level 4	自立実施	任せられる！
----------------	-------------	--------

Level 5	他者を指導	教える側になる
----------------	--------------	---------

「この研修医にこの行動を任せられるか？」が評価の核心

「評価者」から「コーチ」へ

	従来の指導医	CBE のコーチ
スタンス	「できなかったこと」を指摘	「できるようになったこと」を確認
フィードバック	年に 1-2 回の総括評価	日常的な短い対話
目的	合否判定	成長支援
関係性	上下関係	伴走・協働

「あの先生は厳しい」と言われる指導医から、
「あの先生がいると安心」と言われるコーチへ。

日本での動き

- 総合診療専門医制度（2017 年～）で EPA 的評価が導入され始めている
- 初期研修の「行動目標」が実質的な EPA に相当
- USMLE Step 1 の「Pass/Fail」化（2022 年）が全米で「点数から能力へ」の潮流を加速
- 日本の OSCE（客観的臨床能力試験）も「できる」を測る方向へ進化中
- 3/22 の AI 教育 RCT（保持率 91%）が示すように、AI が CBE を支援する時代が来ている

「点数で評価」から「任せられるかで評価」への転換は、日本でも始まっている

ディスカッション

4 分間 → 全体共有 2 分

あなたの研修現場で、
「点数では測れないが、医師として重要な能力」は何か？
それをどう評価すればいい？

明日からの 1 アクション

- 研修医の「できること」を 1 つ、EPA の Level で評価してみる
- 「できなかったこと」ではなく「できたこと」をフィードバックする
- 「次はこれを任せてみようか」という対話を、1 回してみる



2026-03-21 | ■■■ PPTX

デジタル時代のナラティブ・メディスン

物語の力 x 臨床思考 x デジタルツールの統合

研修医・専攻医向け | 30 分 | 2026-03-21

導入の問い

最近診た患者さんの中で、病歴だけでは捉えきれなかった「何か」を感じた経験はありますか？

この 30 分の後、あなたは：

- ナラティブ・メディスンの理論的背景を説明できる（理解）
- デジタル・ナラティブの可能性と限界を論じられる（分析）
- 臨床思考との統合アプローチを 1 つ導入する計画を立てられる（創造）

ナラティブ・メディスンとは

Rita Charon のフレームワーク（Columbia, 2001）

要素	意味	臨床での実践
Attention	注意深く聴く	患者の語りに意識を向ける
Representation	物語を表現する	聴いたことを言語化・記録する
Affiliation	繋がりを形成する	患者との治療的関係を深める

ナラティブ・メディスン = 患者の物語を医療の中核に据えるアプローチ。
「聴く→表現する→繋がる」の3つのステップで、医師 - 患者関係を深める。

ナラティブ教育の現実 — 4つの構造的障壁

Frontiers in Medicine, 2026

☒ カリキュラム過密

ナラティブ教育の時間確保が困難

☒ 教員の準備不足

ナラティブを教えるトレーニングが未体系化

☒ 評価方法の不整合

ナラティブ能力をどう測定するか未解決

☒ 長期アウトカム研究の不足

ケアの質・燃え尽き防止への効果が未検証

構造的な障壁を無視すると形骸化する — システム思考で「レバレッジポイント」を見極めよう

デジタル・ナラティブ・メディシンの登場

JMIR, 2026 — デジタルがナラティブを拡張する 3 つの方向

患者 エンパワーメント

共同設計（co-design）
患者参加型ケア
アドボカシー

ケアチームの 人間化

物語のデジタル可視化
カルテを超えた記録
人間化の架け橋

教育への応用

AI 構造化分析
共感教育の支援
臨床推論との統合

限界： デジタルデバイド | プライバシー | 構造化が物語の豊かさを損なうリスク

ナラティブ x 臨床思考の統合

BMC Medical Education, 2025 — 神経内科での実証

項目	内容
方法	ナラティブ + 臨床思考 vs 従来教育
結果	統合群が有意に高い学習成果
意味	ナラティブと臨床思考は相補的

統合モデル概念図

患者の物語
↓ Attention
物語の構造化
↓ 臨床思考モデル適用
仮説生成 ↔ パターン認識
↓ Affiliation
統合的臨床判断

批判的吟味

- Study Design: 単施設、サンプルサイズは？
- 「高い学習成果」の測定方法は適切か？
- 一般化可能性と教育者効果の交絡は？

ペアディスカッション

4 分間 → 全体共有 2 分

あなたの臨床現場で、ナラティブ x 臨床思考 x デジタルツールの統合を 1 つ実践するとしたら、何ができるか？

考えるヒント

- 外来の問診にナラティブの要素を 1 つ追加するなら？
- カンファレンスで「患者の物語」を構造的に共有する方法は？
- デジタルツール（音声記録、テンプレート等）をどう使えるか？

3つの論文が示す全体像

論文	視点	あなたの臨床に
Frontiers	理想と障壁	現場の制約を知って設計
JMIR	デジタルの可能性	障壁を突破するツール
BMC	統合の実証	物語 + 構造が効くエビデンス

来週までの1アクション（1つ選ぼう）

- 患者の語りに3分間、中断せず耳を傾けてみる
- カルテ「現病歴」に患者の言葉を1文そのまま記載
- 同僚と「心に残った患者の物語」を1つ共有

持ち帰りの問い：デジタルツールが「記録」を便利にする一方で、
聴く力そのものはテクノロジーでは代替できない。
デジタル時代に「聴く力」をどう育むか？



2026-03-21 | ■■■■ PPTX

患者さんの「物語」をケアに活かす

デジタル時代のナラティブ・ケア入門

全スタッフ向け | 15 分 | 2026-03-21

ある日の退院時に

「先生の治療も嬉しかったけど、
あの看護師さんが毎朝
"今日はどんな夢を見ましたか？"
って聞いてくれたのが
一番の薬だったよ。」

今日のゴール

- 「ナラティブ・ケア」の考え方がわかる
- 自分の業務で患者さんの物語を活かす方法を 1 つ挙げられる

ナラティブ・ケアって何？

ナラティブ = 物語。患者さんの物語に耳を傾け、ケアに活かすこと。

病歴（データ）	物語（ナラティブ）
2 型糖尿病，HbA1c 8.2%	「妻が作る煮物が甘くて…でもそれが楽しみ」
左大腿骨頸部骨折	「孫の運動会を見に行きたかった…」
不眠症	「夫を亡くしてから、隣が空いてるのが怖い」

左が「何の病気か」。右が「どんな人生か」。
両方わかると、もっと良いケアができる。

物語を聴くと、何が変わる？

最新の研究でわかったこと

☒ 患者さんのストレスが軽減

物語を聴いてもらえた患者は不安や孤立感が減る

☒ 医療者の判断の質が向上

患者の背景を知ると、より適切な治療選択ができる

☒ チームケアが深まる

物語の共有で多職種連携が改善する

ただの「優しさ」ではなく、ケアの質を上げるスキル

あなたの職種だからこそ 聴ける物語がある

職種	いつ聴ける？	どんな物語？
☒ 看護師	バイタル測定中、ケア中	日常の不安、希望、家族のこと
☒ 介護士	入浴介助、食事介助中	生活歴、こだわり、好きなもの
☒ 事務職員	受付、会計時	通院の困りごと、第一印象
☒ 薬剤師	服薬指導中	薬への不安、生活リズム

どの職種も、患者さんにとって大切な「聴いてくれる人」になれます

みんなで考えよう

グループワーク | 3 分間

最近、患者さんから聴いた
「心に残った一言」はありますか？
それをチームにどう共有したら、
ケアが良くなると思いますか？

話すヒント

- 大きなエピソードじゃなくて OK
- 「もっと聴きたかったけど時間がなかった」でも OK
- 守秘義務の範囲で（個人が特定されない形で）

明日からできる「1日1聴」チャレンジ

職種	1日1聴アクション
看護師	バイタル測定るとき「今日の気分はどうですか?」と聴く
介護士	食事介助るとき「好きな食べ物の思い出」を1つ聴く
事務	受付で「今日はどうやって来られましたか?」と声をかける
全員	聴いた一言を、申し送りノートに1行だけ書く

「聴く」ことは、特別なスキルではなく、
あなたがすでに毎日やっていることの延長線上にあります。

☒ 参考文献リスト（別紙配布）



Multi Agent Ai Slides Allstaff

education/archive/2026-03-21_multi-agent-ai-healthcare/multi-agent-ai_slides_allstaff.pdf

AI が病院で どう使われ始めているか

最新研究から見える未来

全スタッフ向け | 15 分 | 2026-03-21

AI って結局なに？

まずはここから！

- ☒ 「ChatGPT に質問したことがある人？」 → きっと多い
 - ☒ 「AI に仕事を任せたことがある人？」 → きっと少ない
- ここが今日のテーマ！

今日のゴール

- 「AI エージェント」がどういうものかイメージできる
- 医療 AI が自分の業務にどう関わるか考えられる

「質問に答える AI」から 「仕事をする AI」へ

	今までの AI	これからの AI
例え	辞書・百科事典	新人スタッフ
できること	聞いたことに答える	指示を受けて自分で動く
イメージ	「〇〇って何? 」→回答	「業務お願い」→自分で判断

身近な例

- 「検査結果をチェックして異常値があったら教えて」
- 「退院サマリーの下書きを作って」
- 「患者データを集計してグラフにして」

チームで働く AI

Mount Sinai 病院の研究：

「AI も、1 人より「チーム」の方が良い仕事をする」

チーム医療	チーム AI
医師が方針を決める	リーダー AI が全体を管理
看護師が観察・ケア	データ確認 AI が異常を検知
薬剤師が薬をチェック	薬剤チェック AI が確認
事務が書類を整理	書類 AI が記録を整理

正確

チーム AI > 1 人の AI

65 分の
1

コスト削減

品質維持

仕事が増えても

まさに、チーム医療の AI 版！

AI は味方です

⚠ よくある心配とお答え

「仕事を奪われるのでは？」

→ 電子カルテ導入で人が不要になりましたか？ むしろ人間にしかできない業務に集中できるようになった。AI も同じです。

「信頼できるの？」

→ だからこそ「チーム」が大事。1つのAIが間違えても、他がチェックする。

AI が得意なこと → 定型作業、データ処理、パターン検出
人間が得意なこと → 共感、判断、患者さんとの対話

みんなで考えよう

グループワーク | 3 分間

あなたの業務の中で、
「これ、AI に手伝ってもらえたら助かるなあ」
と思うことはありますか？

考えるヒント

- 毎日繰り返している定型作業は？
- 「もう 1 人いたらなあ」と思う場面は？
- データの入力や転記で時間を取られることは？

これからどうなる？

時期	予想される変化
今～1年後	書類作成・データ集計の補助が普及
1～3年後	検査結果の自動チェック・アラートが標準化
3～5年後	チーム AI が日常的に業務を支援

テクノロジーは変わっても、
患者さんの手を握れるのは、あなただけです。

AI が得意なことは AI に。
人間にしかできないことに、もっと時間を使えるように。



Multi Agent Ai Slides Residents

education/archive/2026-03-21_multi-agent-ai-healthcare/multi-agent-ai_slides_residents.pdf

AI が病院でどう働くか

マルチエージェント AI の医療実証研究 — Mount Sinai 論文を読む

研修医・専攻医向け | 30 分 | 2026-03-21

導入の問い

もし優秀な医師が 1 人いるのと、
それぞれの専門が違う普通の医師が 5 人いるチームと、
どちらに難しい症例を任せたいですか？

この 30 分の後、あなたは：

- マルチエージェント AI の基本概念を説明できる（理解）
- Mount Sinai 研究の Study Design を批判的に吟味できる（分析）
- 自分の臨床現場での AI 活用可能性を 1 つ提案できる（創造）

医療 AI の進化 — 3 つの世代

世代	特徴	医療での例
第 1 世代：ルールベース	人間がルールを書く	処方チェックシステム
第 2 世代：生成 AI	1 つの AI が何でもやる	ChatGPT に症例を聞く
第 3 世代：エージェント AI	専門 AI チームが協力	複数 AI が分担して診断支援

マルチエージェント = チーム医療の AI 版

[Supervisor Agent] (総合医)
├── [Agent A] 検査データ専門
├── [Agent B] 画像診断専門
├── [Agent C] 薬剤相互作用専門
└── [Agent D] ガイドライン照合専門

チーム医療と同じ構造
1 人の総合医がすべてやるより
専門家チームの方が強い

Mount Sinai 研究の結果

npj Health Systems, 2026

精度

**有意に
上回る**

特に複雑な
医療タスクで顕著

コスト

65 分の 1

計算コストを
大幅削減

スケール

**性能
維持**

タスク増加でも
品質低下なし

救急外来で 10 人同時搬送：スーパードクター 1 人 → 限界 / 専門チーム 5 人 → 並列処理 + 専門性

批判的吟味

観点	強み	限界・疑問
新規性	医療でのマルチエージェント実証は少ない	実臨床にどれだけ近いタスクか？
定量性	65 倍のコスト削減は具体的	ベンチマーク選定は適切か？
再現性	Mount Sinai の信頼性	他施設での再現は？
臨床的意義	チーム医療と同構造	患者アウトカムは直接示されているか？
安全性	—	判断ミスの検出機構は？

考えるべき問い

- 65 倍のコスト削減 — 比較対象は公平か？
- 統計的有意 ≠ 臨床的有意
- エージェント誤判断時の安全装置は？
- 日本の医療にそのまま適用できるか？

ペアディスカッション

4 分間 → 全体共有 2 分

あなたの臨床現場（外来・病棟・救急）で、
マルチエージェント AI が活躍できそうな場面を
1 つ考えてください。
どんな「専門エージェント」が必要ですか？

考えるヒント

- 複数の情報源を同時に確認する場面は？
- 「誰かに自動チェックしてほしい」業務は？
- カンファレンスの事前準備を効率化するなら？

業界トレンド

1,445%

問い合わせ急増
(Gartner)

3 倍

タスク完了速度

60%↑

精度向上

human-in-the-loop	human-on-the-loop
AI が提案→人間が毎回承認	AI が自律実行→人間が監督
安全だが遅い	速いが信頼性設計が重要

「人間がチェックしなくてもいい AI」は、医療でどこまで許されるか？

持ち帰りの問い

来週の 1 アクション

- 自分の業務で「複数情報を同時確認する場面」を 1 つメモ
- 同僚と「AI に任せたい業務」について 1 回話す
- Mount Sinai 論文の Abstract を読んでみる

チーム医療では「誰が最終責任を負うか」が明確です。
マルチエージェント AI では、誰が責任を負うのでしょうか？

— この問いは、AI の技術問題ではなく、医療倫理の問題です。



Ai Agent Team Overview Slides

meta/2026-03-28_ai-agent-team-overview/ai-agent-team-overview_slides.pdf

AI Agent Team

学びをデザインする 9 人のエージェント会社

9

Agents

Learning Design Lab | CEO: たまさん (家庭医 × 教育者 × AI 実践者)

なぜ AI エージェントチーム？

課題

情報過多：医療 × AI × 教育、毎日膨大な情報が流れる

時間不足：臨床・教育・研究の合間に処理しきれない

発信したい：学びを届けたいが制作時間が足りない

解決策

9 人の AI エージェントが 24 時間稼働

情報収集→分析→教材→コンテンツを自動化

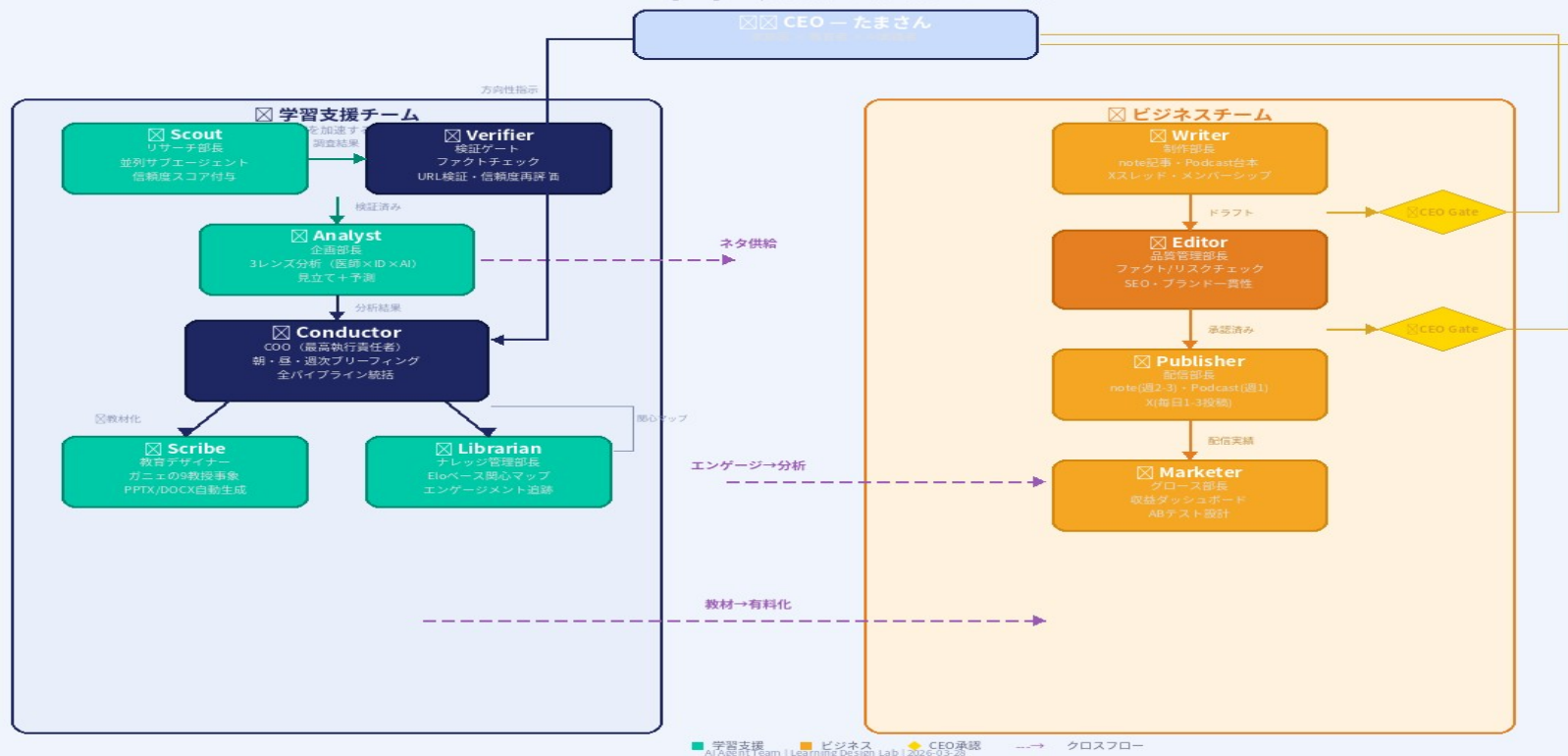
たまさんは「判断」と「声」に集中

一人会社だけど、チームで動く — それが AI エージェントカンパニー

チーム相関図

AI Agent Team — チーム相関図

Learning Design Lab | 学びをデザインする9人のエージェント会社



☒ 学習支援チーム

たまさんの学びを加速する 6 エージェント

Scout

リサーチ部長

Verifier

検証ゲート

Analyst

企画部長

Conductor

COO

Scribe

教育デザイナー

Librarian

ナレッジ管理

Scout → Verifier → Analyst → CEO 判断 → Scribe → Librarian

Scout & Verifier — 情報収集と検証

Scout — リサーチ部長

- 並列サブエージェントで 4 クラスター同時調査
- 一次ソース（論文・公式）と二次ソース（まとめ）を区別
- 信頼度スコア（high/medium/low）付与
- トリガー：/scout [トピック]

Verifier — 検証ゲート

- Scout 出力のファクトチェック
- URL 検証・ソース到達確認
- 信頼度の再評価
- パイプライン上の品質フィルター

Analyst & Scribe — 分析と教材化

Analyst — 企画部長

- 3つのレンズで深掘り（医師 ×ID×AI）
- Conductor の見立て+予測
- 独自の切り口を発見
- トリガー：/analyst [トピック]

Scribe — 教育デザイナー

- ガニエの9教授事象に基づく設計
- 対象者別出力（研修医・全職員）
- PPTX + DOCX 自動生成
- トリガー：/scribe [トピック]

Conductor & Librarian — 統括とナレッジ

Conductor — COO（最高執行責任者）

- 朝・昼・週次の3モードブリーフィング
- 全パイプラインのオーケストレーション
- 承認ゲート管理
- トリガー：/briefing

Librarian — ナレッジ管理部長

- Elo ベースの関心マップ（50 トピック）
- ♥ エンゲージメント追跡
- 週次レトロスペクティブ
- トリガー：/librarian

☒ ビジネスチーム

学びを届ける 4 エージェント

Writer

制作部長

Editor

品質管理部長

Publisher

配信部長

Marketer

グロース部長

Scout → Analyst → CEO → Writer → Editor → CEO → Publisher → Marketer

コンテンツの 4 本柱

学び方のデザイン

AI エージェント一人会社

家庭医の視点

趣味で学ぶ ID

Writer & Editor — 制作と品質保証

Writer — 制作部長

フォーマット	内容
note 無料	学び方のデザイン・AI 活用
note 有料	深掘り分析・実践ガイド
Podcast 台本	対話形式・20-30 分
X スレッド	要点まとめ・速報
メンバーシップ	限定コンテンツ・Q&A

トリガー : /writer [テーマ]

Editor — 品質管理部長

- 文章品質
- ファクトチェック
- リスクチェック（医師法・薬機法）
- SEO・発見性
- ブランド一貫性

トリガー : /editor [ファイル]

CEO ゲート : Writer→Editor の出力はたまさんの最終承認が必要

Publisher & Marketer — 配信と成長

Publisher — 配信部長

note.com — 週 2-3 本

Podcast — 週 1 回・20-30 分

X — 毎日 1-3 投稿

教育モード : Scribe 出力→ PPTX/DOCX

トリガー : /publisher [ファイル]

Marketer — グロース部長

- フォロワー / リスナー数トラッキング
- 収益ダッシュボード
- 成長戦略立案
- AB テスト設計

トリガー : /marketer

パイプライン全体像 — 学習からビジネスへ

学習パイプライン



↓ クロスフロー：調査結果→ネタ元 / 教材→有料コンテンツ ↓

ビジネスパイプライン



学習チームの調査結果がビジネスチームのネタ元に。Scribe の教材が有料コンテンツに。

進化ロードマップ

Phase 1 (Now)

基盤強化

- cron 安定化・認証セッション維持
- モバイル連携（Claude Code Channels）
- ダッシュボード改善

Phase 2 (Next)

自律化

- 秘書 Agent（進捗横断管理）
- A2A プロトコル（エージェント間通信標準化）
- n8n ワークフロー（可視化・エラー通知）

Phase 3 (Future)

マルチ LLM 拡張

- Gemini 連携（長文コンテキスト活用）
- NotebookLM（ポッドキャスト自動生成）
- 外部 API 統合

注目アイデア 4 選

1 秘書 Agent

「誰がどこまで進んだか」を横断管理。Conductor の負荷分散

2 A2A プロトコル

Agent Card によるサービスディスカバリ。動的ルーティング

3 n8n ワークフロー

パイプラインの可視化。エラー通知・リトライ一元管理

4 Gemini × NotebookLM

マルチ LLM 活用。ポッドキャスト音声自動生成の可能性

Vision — たまさんが判断に集中できる世界

情報収集・分析・制作・配信…すべてをエージェントが担い、
たまさんは「何を学ぶか」「何を届けるか」の判断だけに集中する

現在

週 5-8 時間の関与（方向性決定・最終承認・声入れ）

目標

判断以外の作業時間をゼロに近づける

最終形

学びと発信が自然に回り続けるエコシステム